

پرسش‌ها و پاسخ‌های تشریحی

سومین آزمون صلاحیت حرفه‌ای

روان‌شناسان و مشاوران

این مجموعه شامل نسخه اولیه از پاسخ‌های تحلیلی به سؤالات آزمون اخیر بوده است. نسخه‌های تکمیلی شامل توضیحات بیشتر، تحلیل‌های عمیق‌تر به همراه سؤالات دقیق‌تر به‌زودی منتشر خواهد شد.

لطفاً برای دریافت آخرین به‌روزرسانی‌ها و نسخه‌های نهایی، تنها کانال رسمی من را دنبال فرمایید:

<https://t.me/drtorkamannezam>

با احترام

دکتر محمد ترکمان

نسخه ۲ - تاریخ انتشار: ۱۱/۵/۱۴۰۴

تذکر مهم ۱

این سؤالات و پاسخ‌های تحلیلی صرفاً بر اساس برداشت شخصی و دانش تخصصی نگارنده تهیه شده و به هیچ وجه تأییدکننده سؤالات واقعی آزمون یا پاسخ‌نامه رسمی سازمان سنجش یا سازمان نظام روانشناسی نیست.

انتشار این مطالب صرفاً با هدف تحلیل آموزشی و بحث علمی است و هرگونه استفاده دیگر خارج از این چارچوب مورد نظر نویسندگان نمی‌باشد.

تذکر مهم ۲

تلاش شده است که با مرور منابع، پاسخ سؤالات به دقت انتخاب شود اما ممکن است در برخی سؤالات محدود، پاسخ انتخاب شده با پاسخ طراح، مغایر باشد. ملاک پاسخ‌ها طبقاً سازمان سنجش و سازمان نظام است. همچنین متن سؤال و گزینه‌ها ممکن است با اصل آزمون فرق کند چون به سؤالات دسترسی نداشتیم.

۱. در اتاق درمان مراجع قصد حمله به مشاور یا روان‌شناس را دارد بهترین واکنش کدام است؟

• (۱) توقف فرایند درمانی

• (۲) تماس با خانواده مراجع

• (۳) بررسی مجدد پرونده مراجع

• (۴) درخواست کمک عاجل به هر شیوه‌ای که امکان‌پذیر باشد.

پاسخ:

گزینه ۴ صحیح است. درخواست کمک فوری به هر شیوه

ممکن. در چنین موقعیت بحرانی، اولویت مطلق با حفظ ایمنی جانی و روانی درمانگر، مراجع و دیگران است. هرگونه اقدام درمانی یا تحلیلی، مانند تلاش برای متوقف کردن درمان، به بعد از کنترل کامل بحران موکول می‌شود، زیرا امنیت مشاور بر هر اصل درمانی دیگری ارجحیت دارد.

۲. اگر در اتاق درمان مراجعی دروغ بگوید عکس‌العمل شما چگونه خواهد بود؟

• (۱) واریسی دلیل دروغ‌گویی و ارائه تفسیر در زمان مطلوب

• (۲) علامت مقاومت است آن را تحلیل می‌کنم

• (۳) ارائه پرسشگری تا آشکار شدن دروغ وی

• (۴) مواجهه مراجع با تناقض‌های خودش

پاسخ:

گزینه ۱ صحیح است. واریسی دلیل دروغ‌گویی و ارائه تفسیر در زمان مطلوب. مواجهه مستقیم و فوری با دروغ مراجع، به‌ویژه در مراحل اولیه درمان، اقدامی صحیح نیست. دروغ‌گویی در فرآیند درمان یک پدیده قابل انتظار است که می‌تواند دلایل متعددی مانند ترس، شرم یا مقاومت داشته باشد. وظیفه درمانگر، مشاهده‌گری دقیق، واریسی و درک دلایل این رفتار و سپس، در زمان مناسب و پس از شکل‌گیری اتحاد درمانی قوی، ارائه تفسیر یا بازخورد سازنده است، نه مچ‌گیری یا مواجهه تقابلی.

۳. مهم‌ترین ابزار سنجش در روان‌شناسی چیست؟

• (۱) آزمون‌ها

• (۲) مشاهده

• (۳) مصاحبه

• (۴) پرسشنامه‌ها

پاسخ:

گزینه ۳ صحیح است. مصاحبه (به‌ویژه مصاحبه تشخیصی).

اگرچه مشاهده و آزمون‌های روان‌شناختی نیز ابزارهای ارزشمندی هستند، اما مصاحبه به عنوان ابزاری پویا که امکان برقراری رابطه، درک زمینه و کاوش عمیق تجربیات ذهنی مراجع را فراهم می‌کند، بنیادی‌ترین و کلیدی‌ترین ابزار یک متخصص بالینی محسوب می‌شود.

۴. هنگامی که توهمات بینایی واضح در یک بیمار مشاهده شوند احتمال کدام مورد بیشتر مطرح می‌شود؟

• (۱) اختلال اضطرابی

• (۲) اختلال عضوی

• (۳) دلیریوم

• (۴) فرار مرضی

پاسخ:

گزینه ۳ صحیح است. دلیریوم (Delirium). اگرچه توهمات در اختلالات روان‌پریشی نیز دیده می‌شوند، اما توهمات شنیداری در اسکیزوفرنی شایع‌تر هستند. وجود توهمات بینایی واضح و شدید، یک نشانه کلیدی برای اختلالات با منشأ عضوی (ارگانیک) است که در میان آن‌ها، دلیریوم به عنوان یک وضعیت اورژانسی پزشکی، محتمل‌ترین تشخیص است و نیازمند توجه فوری می‌باشد.

۵. دانشجویی که پس از قبولی در آزمون کارشناسی ارشد در انتخاب محل تحصیل بین دانشگاه‌های تهران و شهرستان دچار تردید می‌شود کدام نوع تعارض ایجاد می‌شود؟

• (۱) دافع - جاذب

• (۲) جاذب - دافع

• (۳) جاذب - جاذب

• (۴) دافع - دافع

پاسخ:

گزینه ۳ صحیح است. تعارض گرایش-گرایش

(Approach-Approach Conflict) که به آن جاذب-جاذب نیز گفته می‌شود. این نوع تعارض زمانی رخ می‌دهد که فرد باید بین دو گزینه که هر دو مطلوب و جذاب هستند، یکی را انتخاب کند. هیچ یک از گزینه‌ها به وضوح بر دیگری برتری ندارد و هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. به دلیل جذابیت تمام گزینه‌ها، انتخاب یکی از آنها می‌تواند برای فرد دشوار باشد، زیرا هر انتخاب به معنای از دست دادن مزایای انتخاب دیگر است.

۶. در کدام یک از اختلالات زیر هذیان و توهم مشاهده می‌شود؟

- (۱) وسواس
- (۲) اوتیسم
- (۳) هراس اجتماعی
- (۴) روان‌گسیختگی

پاسخ:

گزینه ۴ صحیح است. اختلالات روان‌پریشی (Psychotic

Disorders) مانند روان‌گسیختگی (اسکیزوفرنی). در سایر دسته‌ها مانند اختلالات روان‌رنجوری (نوروتیک) یا اوتیسم، توهم و هذیان جزء نشانه‌های اصلی و تعریف‌کننده اختلال نیستند.

روان‌گسیختگی، اسکیزوفرنی یک اختلال روانی است که با دوره‌های مداوم یا عودکننده روان‌پریشانه مشخص می‌شود. علائم اصلی شامل توهم (غالباً توهم شنیداری)، هذیان و اختلال تفکر است. علائم دیگر عبارتند از کناره‌گیری اجتماعی، کاهش ابراز عواطف و بی‌تفاوتی

۷. در بیماران مبتلا به اختلال روانی شایع‌ترین توهم کدام است؟

• (۱) بویایی

• (۲) شنوایی

• (۳) بینایی

• (۴) چشایی

پاسخ:

گزینه ۲ صحیح است. شایع‌ترین توهم، توهم شنوایی (Auditory Hallucination) است، خصوصاً در اختلالاتی مانند اسکیزوفرنی.

توهم به معنای درک نادرست و غیر واقعی از اتفاقات و رویدادهای پیرامونی است. کسانی که دچار توهم فکری می‌شوند در واقع مبتلا به یک اختلال روان‌پریشی هستند که به واسطه‌ی آن صداهاى غیر واقعی می‌شنوند یا تصاویر غیر واقعی می‌بینند. افراد مبتلا به توهم

۸. هدف از فعال‌سازی رفتاری در درمان افسردگی کدام است؟

• (۱) افزایش درگیری مراجع در فعالیتهای لذت‌بخش و فعالیت مجدد کارکردها

• (۲) ارزیابی احساسات منفی در جلسات

• (۳) حذف فعالیتهای روزمره

• (۴) حذف کامل افکار منفی

پاسخ:

گزینه ۱ صحیح است. افزایش درگیری مراجع در فعالیتهای

لذت‌بخش و معنادار. این تکنیک که از مؤلفه‌های اصلی درمان شناختی-رفتاری (CBT) برای افسردگی است، بر این اصل استوار است که کاهش خلق منجر به کاهش فعالیت و انزوا می‌شود و این انزوا، افسردگی را تشدید می‌کند. فعال‌سازی رفتاری با ترغیب مراجع به انجام فعالیتهای مثبت، حتی در غیاب انگیزه، به دنبال شکستن این چرخه معیوب و افزایش تماس فرد با تقویت‌کننده‌های مثبت محیطی و در نتیجه، بهبود خلق است. اصل کلیدی در این رویکرد آن است که "عمل بر انگیزه مقدم است".

۹. کدام نوع هذیان‌ها خطرناک‌تر هستند؟

• (۱) گزند و آسیب

• (۲) بزرگ‌منشی

• (۳) سازمان یافته

• (۴) نفوذ

پاسخ:

گزینه ۱ صحیح است. هذیان گزند و آسیب

(Persecutory Delusion). در حالی که هذیان نفوذ

(باور به کنترل شدن توسط نیرویی خارجی) نیز نشان‌دهنده

آسیب روانی عمیق است، هذیان گزند و آسیب به دلیل ارتباط

مستقیم با احتمال بروز رفتار پرخاشگرانه، خطرناک‌تر تلقی

می‌شود. فردی که معتقد است دیگران قصد آسیب رساندن به

او را دارند، ممکن است برای «دفاع از خود» به دیگران یا خود

آسیب برساند.

۱۰. نشانه‌های اوتیسم در کدام سن ظاهر می‌شود؟

• (۱) بعد از ۳۶ ماهگی

• (۲) پس از دو سال تحول بهنجار

• (۳) قبل از ۳ سالگی

• (۴) پس از ۱۰ سالگی

پاسخ:

گزینه ۳ صحیح است. قبل از سه سالگی. بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM)، اگرچه تشخیص قطعی ممکن است پس از سه سالگی (مثلاً بعد از ۳۶ ماهگی) گذاشته شود، اما نشانه‌های اصلی اختلال باید در اوایل دوره رشد، یعنی قبل از سه سالگی، ظاهر شده باشند.

علائم اصلی اختلال طیف اوتیسم (اوتیسم) شامل مشکلات در تعاملات اجتماعی، ارتباطات کلامی و غیر کلامی، و رفتارهای تکراری و محدود است. این علائم معمولاً قبل از سه سالگی ظاهر می‌شوند و می‌توانند درجات مختلفی از شدت داشته باشند.

۱۱. کدام مورد نشانگر ارکان مصاحبه بالینی است؟

- (۱) تکنیک‌ها - بررسی وضعیت روانی - تشخیص - درمان
- (۲) رابطه - تکنیک‌ها - بررسی وضعیت روانی - تشخیص
- (۳) بررسی وضعیت روانی - تشخیص - درمان - ارجاع
- (۴) رابطه - تشخیص - بررسی وضعیت روانی - درمان

پاسخ:

گزینه ۲ صحیح است. بر اساس مدل اُتمر (Othmer)، چهار رکن اصلی برای مصاحبه بالینی تعریف شده است: ۱. رابطه (Rapport)، ۲. تکنیک (Technique)، ۳. تشخیص (Diagnosis)، و ۴. ارزیابی وضعیت روانی (Mental Status Examination). درمان (Treatment) اگرچه هدف نهایی فرآیند است، اما جزء ارکان ساختاری خودِ مصاحبه به شمار نمی‌رود. مصاحبه در بستر یک رابطه درمانی و با استفاده از تکنیک‌های مشخص برای رسیدن به تشخیص و ارزیابی وضعیت روانی انجام می‌شود.

۱۲. تظاهر عینی وضعیت بالینی (Objective manifest of pathological situation) بیانگر کدام مورد است؟

• (۱) نشانگان یا syndrome

• (۲) علامت یا Symptom

• (۳) اختلال یا disorder

• (۴) نشانه یا Sign

پاسخ:

گزینه ۴ صحیح است. نشانه (Sign). در آسیب‌شناسی روانی، بین دو مفهوم تمایز وجود دارد: «نشانه» که یک یافته بالینی عینی و قابل مشاهده توسط متخصص است (مانند سراسیمگی روانی-حرکتی) و «علامت» (Symptom) که یک تجربه ذهنی و گزارش‌شده توسط مراجع است (مانند احساس غمگینی). مجموعه‌ای از نشانه‌ها و علائم، یک اختلال (Disorder) را تشکیل می‌دهند.

۱۳. در آسیب‌شناسی روانی رد کردن سایر تشخیص‌های احتمالی نشانگر کدام تشخیص است؟

• (۱) افتراقی

• (۲) همبودی

• (۳) اصلی

• (۴) اولیه

پاسخ:

گزینه ۱ صحیح است. تشخیص افتراقی (Differential

Diagnosis). این یک فرآیند بالینی استاندارد و نظام‌مند است که در آن، درمانگر با بررسی شواهد، سایر اختلالات محتمل که علائم مشترکی با وضعیت مراجع دارند را رد می‌کند تا به دقیق‌ترین تشخیص ممکن برسد. این فرآیند با «همبودی» (Comorbidity) که به معنای وجود همزمان چند اختلال است، تفاوت دارد.

۱۴. نقش عوامل ارثی در ابتلا به اختلال روانی، کدام است؟

• (۱) نگهدارنده

• (۲) آشکارساز

• (۳) مستعد کننده

• (۴) حمایتی

پاسخ:

گزینه ۳ صحیح است. عامل مستعدکننده یا زمینه‌ساز (Predisposing Factor). در مدل دیاتز-استرس، عوامل به چند دسته تقسیم می‌شوند: عوامل زمینه‌ساز (مانند وراثت و ژنتیک) که بستر را برای بروز مشکل فراهم می‌کنند؛ عوامل آشکارساز یا راه‌انداز (Precipitating Factor) که اختلال را فعال می‌کنند (مانند یک رویداد استرس‌زا)؛ و عوامل تداوم‌بخش (Perpetuating Factor) که باعث ادامه یافتن اختلال می‌شوند. عوامل ارثی در دسته اول قرار می‌گیرند.

۱۵. کدام یک از موارد زیر مانع دخالت دادن نیازهای مشاور در فرایند مشاوره می‌شود؟

• (۱) آگاهی از سکوت مراجع

• (۲) مهارت‌های مشاوره

• (۳) فنون به کار رفته در مشاوره

• (۴) انگیزه مشاور شدن

پاسخ:

گزینه ۴ صحیح است. انگیزه مشاور شدن. در حالی که

مهارت‌ها و همدلی به فرآیند درمان کمک می‌کنند، انگیزه‌های ناسالم درمانگر (مانند نیاز به کسب درآمد، شهرت، قدرت یا ارضای نیازهای شخصی) می‌تواند به عنوان یک مانع جدی عمل کرده و به بی‌طرفی و اثربخشی درمان آسیب بزند. پایبندی به اصل مسئولیت‌پذیری و وفاداری (Fidelity and Responsibility) که ریشه در این انگیزه سالم دارد، مانع از چنین دخالتی می‌شود.

۱۶. هنگامی که رفتارهای غیر کلامی مراجع با رفتارهای کلامی او مطابقت ندارد بهتر است از کدام مهارت استفاده شود؟

• (۱) قاب‌گیری

• (۲) مواجهه

• (۳) انعکاس احساس

• (۴) پاسخ کوتاه

پاسخ:

گزینه ۲ صحیح است. مواجهه (Confrontation). تکنیک

مواجهه در روان‌درمانی به معنای بازتاب دادن محترمانه تناقض‌ها و ناهماهنگی‌های موجود در افکار، احساسات و رفتارهای مراجع است. این کار با هدف افزایش خودآگاهی مراجع انجام می‌شود و باید با ظرافت و تنها زمانی به کار رود که یک اتحاد درمانی قوی شکل گرفته باشد تا مراجع آن را حمله‌ای به خود تلقی نکند و با «مواجهه درمانی» (Exposure Therapy) که برای درمان اضطراب به کار می‌رود، متفاوت است.

۱۷. مهمترین تکنیک در برقراری رابطه مؤثر، کدام است؟

- (۱) گوش دادن فعال
- (۲) اطمینان دادن
- (۳) انعکاس احساسات
- (۴) سازمان‌دهی

پاسخ:

گزینه ۱ صحیح است. گوش دادن فعال (Active

Listening). اگرچه تکنیک‌های دیگری مانند انعکاس، همدلی و خلاصه‌سازی نیز اهمیت دارند، اما گوش دادن فعال به عنوان اساس و قلب فرآیند مشاوره، بنیادی‌ترین مهارت برای ایجاد یک رابطه درمانی قوی و درک عمیق دنیای مراجع است.

گوش دادن فعال به این معناست که شنونده با دقت و تمرکز کامل به صحبت‌های گوینده گوش می‌دهد، سعی می‌کند پیام او را به طور کامل درک کند و با پرسیدن سؤالات و بازخوردهای مناسب، اطمینان حاصل کند که پیام را به درستی فهمیده است. این نوع گوش دادن فراتر از شنیدن صرف کلمات است و شامل درک احساسات و منظور گوینده نیز می‌شود.

۱۸. هدف از گرفتن رضایت آگاهانه (Informed Consent) در آغاز درمان کدام است؟

- (۱) جلوگیری از شکایت‌های حقوقی
- (۲) اجبار قانونی بدون کاربرد درمانی
- (۳) گرفتن تعهد برای پرداخت هزینه‌ها
- (۴) مطلع کردن مراجع از فرایند درمان، محدودیت‌ها و حقوق وی

پاسخ:

گزینه ۴ صحیح است. مطلع کردن مراجع از فرایند درمان و حقوقش. هدف اصلی رضایت آگاهانه، احترام به اصل خودمختاری مراجع و تضمین این است که او به طور کامل از ماهیت درمان، هزینه‌ها، حدود رازداری و استثنائات آن، و حقوق قانونی خود مطلع باشد تا بتواند تصمیمی آزادانه و آگاهانه بگیرد. اگرچه این فرایند می‌تواند به جلوگیری از شکایت‌های آتی نیز کمک کند، اما این هدف فرعی است و هدف اصلی، تحقق حق مراجع برای دانستن است.

۱۹. در کدا نوع درمانگری بازسازی شناختی انجام می‌شود؟

- (۱) طرحواره درمانی
- (۲) رفتار درمانی شناختی
- (۳) درمان‌های موج اول و دوم
- (۴) درمان‌های موج سوم

پاسخ:

گزینه ۲ صحیح است. درمان شناختی-رفتاری

(Cognitive-Behavioral Therapy - CBT). این

تکنیک، هسته اصلی درمان‌های شناختی (موج دوم) را تشکیل می‌دهد که در آن به مراجع کمک می‌شود تا افکار ناکارآمد و تحریف‌شده خود را شناسایی، ارزیابی و با افکار واقع‌بینانه‌تر جایگزین کند. این رویکرد با درمان‌های موج سوم (مانند ACT) که بر پذیرش افکار به جای به چالش کشیدن آن‌ها تأکید دارند، متفاوت است.

۲۰. از نو قالب‌گیری کردن به کدام معنای زیر است؟

- (۱) ایجاد رویدادهایی از تاریخچه خانوادگی
- (۲) کاهش پویایی‌های اغراق‌آمیز مسائل جدی
- (۳) ایجاد دیدگاه جدید و بینش بیشتر
- (۴) ایجاد تغییر در روابط اعضای خانواده

پاسخ:

گزینه ۳ صحیح است. ایجاد دیدگاه جدید و بینش بیشتر. در این تکنیک، درمانگر با ارائه یک دیدگاه جایگزین، به مراجع کمک می‌کند تا معنای متفاوتی برای تجربیاتش بیابد و در نتیجه، واکنش هیجانی و رفتاری متفاوتی نشان دهد. این کار به معنای ایجاد بینش جدید و افزایش انعطاف‌پذیری شناختی است.

برای مثال فردی که به دلیل عدم موفقیت در یک آزمون ناراحت است، ممکن است با استفاده از قاب‌بندی مجدد، این شکست را به عنوان فرصتی برای شناسایی نقاط ضعف خود و تلاش برای بهبود در آینده در نظر بگیرد. در این حالت، به جای اینکه خود را فردی شکست‌خورده بداند، از این تجربه به عنوان یک فرصت برای یادگیری و رشد استفاده می‌کند.

۲۱. فعال شدن همزمان چند طرحواره و سبک مقابله‌ای نشانه چیست؟

- (۱) ذهنیت
- (۲) خطاهای شناختی
- (۳) اجتناب تجربه‌ای
- (۴) انعطاف‌ناپذیری روان‌شناختی

پاسخ:

گزینه ۱ صحیح است. ذهنیت (Mode). ذهنیت‌ها،

حالت‌های هیجانی و رفتاری لحظه‌به‌لحظه‌ای هستند که وقتی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه فعال می‌شوند، فرد آن‌ها را تجربه می‌کند (مانند ذهنیت کودک آسیب‌پذیر، والد تنبیه‌گر یا محافظ بی‌تفاوت).

به عبارت دیگر، ذهنیت‌ها الگوهای نسبتاً پایداری از تفکر، احساس و رفتار هستند که در پاسخ به موقعیت‌های مختلف، به طور موقت فعال می‌شوند. این الگوها می‌توانند شامل احساسات، افکار و رفتارهای خاصی باشند که فرد در یک لحظه تجربه می‌کند.

۲۲. طبق درمان شناختی رفتاری نسبت دادن کاهش میزان بارندگی به نوع پوشش بانوان چه نوع خطای شناختی است؟

- (۱) ذهن خوانی
- (۲) استنباط دلخواهی
- (۳) انتزاع انتخابی
- (۴) مقایسه‌های ناعادلانه

پاسخ:

گزینه ۲ صحیح است. استنباط دلخواهی (Arbitrary

Inference). این خطای شناختی به نتیجه‌گیری شتاب‌زده و بدون شواهد کافی، یا حتی با وجود شواهد متناقض، اشاره دارد. در این نوع تفکر، فرد بر اساس باورهای شخصی خود، یک رابطه علی-معلولی غیرواقعی بین دو پدیده برقرار می‌کند.

۲۳. مهم‌ترین تکنیک در طرحواره درمانی چیست؟

• (۱) میان فردی

• (۲) کشف سائق‌ها

• (۳) تجربی

• (۴) رابطه‌ای

پاسخ:

گزینه ۳ صحیح است. تکنیک‌های تجربی (Experiential

Techniques). این تکنیک‌ها (مانند تصویرسازی ذهنی و کار با صندلی خالی) با هدف قرار دادن هیجانات مرتبط با طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، به بازپردازش هیجانی خاطرات کودکی و تغییر الگوهای ریشه‌دار کمک می‌کنند و هسته اصلی و متمایزکننده این رویکرد درمانی را تشکیل می‌دهد.

۲۴. کدام مورد در خصوص شاغلین حرفه‌های روان‌شناسی و مشاوره صحیح است؟

• (۱) «شماره عضویت نظام روان‌شناسی و مشاوره» و «شماره پروانه اشتغال» فقط برای مقطع کارشناسی ارشد متفاوت است.

• (۲) «شماره عضویت نظام روان‌شناسی و مشاوره» و «شماره پروانه اشتغال» فقط برای مقطع دکتری متفاوت است.

• (۳) «شماره عضویت نظام روان‌شناسی و مشاوره» و «شماره پروانه اشتغال» دو مدرک متفاوت است.

• (۴) «شماره عضویت نظام روان‌شناسی و مشاوره» و «شماره پروانه اشتغال» معادل و یکسان است.

پاسخ:

گزینه ۳ صحیح است. عضویت در سازمان نظام روان‌شناسی و پروانه اشتغال دو مقوله متفاوت هستند. عضویت صرفاً به معنای پذیرفته شدن به عنوان عضوی از سازمان است و یک پیش‌نیاز برای درخواست پروانه محسوب می‌شود. اما پروانه اشتغال، مجوزی است که پس از احراز صلاحیت‌های لازم (از جمله قبولی در آزمون صلاحیت حرفه‌ای) صادر می‌شود و به فرد اجازه کار درمانی مستقل را می‌دهد.

۲۵. کدام مورد در خصوص ارزش و اعتبار پروانه‌های فعالیت حرفه‌ای روان‌شناسان و مشاوران صحیح‌تر است؟

• (۱) کلیه پروانه‌های صادره از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره اعتبار برابر و یکسانی دارند.

• (۲) پروانه‌های صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعتبار بیشتری دارد.

• (۳) پروانه‌های صادره بر اساس آزمون صلاحیت حرفه‌ای اعتبار بیشتری دارد.

• (۴) پروانه‌های صادره از درگاه ملی صدور مجوزها، اعتبار بیشتری دارد.

پاسخ:

گزینه ۱ صحیح است. کلیه پروانه‌هایی که توسط سازمان نظام روان‌شناسی به عنوان نهاد قانونی صادر می‌شوند، ارزش و اعتبار یکسانی دارند. هیچ تمایز و برتری بین مدارک و پروانه‌ها نیست و همه قانونی هستند.

۲۶. اگر بخواهید در استانی مشغول به کار مشاوره و روان‌درمانی شوید که دارای بافت فرهنگی متفاوت با شما است، بهترین اقدام چیست؟

• (۱) بر اساس الگوهای فرهنگی کلی کشور به ارائه خدمات می‌پردازم.

• (۲) فرایند مداخله در این فرهنگ مبتنی بر گشودگی ذهن مراجعان است.

• (۳) خدمات مشاوره و روان‌شناختی در تمام بافت‌های فرهنگی کارایی یکسان دارند.

• (۴) آشنایی با فرهنگ بوم شناختی و مدنظر قرار دادن ارزش‌های آن فرهنگ در مداخله

پاسخ:

گزینه ۴ صحیح است. آشنایی با مسائل فرهنگی و بوم‌شناختی آن استان و متناسب‌سازی مداخلات. درمانگر موظف است با شناخت فرهنگ، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه‌ای که در آن کار می‌کند، خدمات خود را به شیوه‌ای حساس و متناسب با آن بافت فرهنگی ارائه دهد.

۲۷. نظر شما در زمینه انجام مشاوره و مداخله روان‌شناختی در ویلاهای شخصی یا باغ بر اساس درخواست مراجع چیست؟

• (۱) مخالفت می‌کنم

• (۲) در صورت مطلوب بودن شرایط ویلا یا باغ موافقت می‌کنم

• (۳) اگر غیر از مراجع افراد دیگری نیز حضور داشته باشند موافقت می‌کنم

• (۴) اگر خانواده مرفه باشند و ذهن آنها گشوده باشد، مشکلی نخواهم داشت.

پاسخ:

گزینه ۱ صحیح است. مخالفت قاطع. جلسات مشاوره باید صرفاً در چارچوب حرفه‌ای و در اتاق درمان برگزار شود. پذیرش چنین درخواست‌هایی مصداق بارز خروج از چارچوب، رابطه دوگانه و نقض مرزهای حرفه‌ای است که اکیداً ممنوع می‌باشد.

۲۸. شایستگی حرفه‌ای در رشته‌های روان‌شناسی و مشاوره به کدام معنی است؟

• (۱) داشتن پروانه تخصصی

• (۲) توانمندی در تشخیص و درمان

• (۳) رعایت تعرفه

• (۴) عدم تجویز دارو

پاسخ:

گزینه ۱ و ۲ صحیح است. از منظر قانونی و نظارتی، شایستگی حرفه‌ای با «داشتن پروانه تخصصی» احراز می‌شود. اگرچه جوهر اصلی شایستگی، «توانمندی در تشخیص و درمان مناسب» است، اما پروانه نشان‌دهنده احراز حداقل‌های آموزشی، قبولی در آزمون صلاحیت و قرار گرفتن تحت نظارت و پاسخگویی به یک نهاد قانونی (سازمان نظام روان‌شناسی) است. لذا گزینه داشتن پروانه تخصصی و گزینه توانمندی در تشخیص و درمان می‌توانند درست باشد.

گرچه احتمال می‌رود که طراح بیشتر روی گزینه ۱ تاکید داشته باشد.

۲۹. اگر شکایتی از درمانگر به سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره شود به چه میزان باید با سازمان همکاری شود؟

• (۱) روان‌شناس مستقل است مسئولیتی متوجه سازمان نیست.

• (۲) در رسیدگی به شکایت با سازمان همکاری می‌کنم

• (۳) شخصاً موضوع را با مراجع حل و فصل می‌کنم

• (۴) شکایت باید در دادگاه بررسی شود.

پاسخ:

گزینه ۲ صحیح است. در رسیدگی به شکایت با سازمان

همکاری می‌کنم. بر اساس اصول اخلاق حرفه‌ای، روان‌شناس موظف است نهایت همکاری را با نهادهای نظارتی داشته باشد و اطلاعات لازم را در اختیار آن‌ها قرار دهد.

۳۰. چنانچه در فرایند درمان به موفقیت نائل نشوید چه کاری باید انجام شود؟

- (۱) درمان را متوقف می‌کنم
- (۲) با رویکرد دیگری درمان را ادامه می‌دهم.
- (۳) ارجاع می‌دهم
- (۴) جلسات درمان را بیشتر می‌کنم

پاسخ:

گزینه ۳ صحیح است. ارجاع دادن مراجع. ادامه درمانی که مؤثر واقع نشده، غیراخلاقی است. ارجاع به یک متخصص دیگر (شاید با رویکردی متفاوت) یک خدمت تخصصی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده اولویت دادن به بهزیستی مراجع بر منافع شخصی یا حرفه‌ای درمانگر است. متوقف کردن درمان بدون ارائه گزینه جایگزین، اقدام صحیحی نیست.

۳۱. وقتی مراجع برای برخورد با دیگران خطرساز باشد چه اقدامی باید انجام داد؟

• (۱) اطرافیان او را آگاه می‌کنم

• (۲) رازداری را حفظ می‌کنم

• (۳) صبر می‌کنم تا خطر رفع شود.

• (۴) نادیده می‌گیرم

پاسخ:

گزینه ۱ صحیح است. رازداری نقض می‌شود و باید اطرافیان یا مقامات مسئول را آگاه کرد. این اصل که به عنوان «وظیفه حمایت» (Duty to Protect) شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین استثنائات رازداری است. زمانی که خطر آسیب جدی و قریب‌الوقوع برای دیگران وجود دارد، تعهد درمانگر برای حفظ امنیت جامعه بر تعهد او به رازداری اولویت پیدا می‌کند.

۳۲. درمانگر حرفه‌ای پرونده مراجعین را چگونه نگهداری می‌کند؟

- (۱) نگهداری در منزل
 - (۲) حذف پس از درمان
 - (۳) جهت نگهداری در اختیار مرکز قرار می‌دهد.
 - (۴) نگهداری امن اطلاعات بر اساس اصول رازداری در محل درمان و مشاوره
- پاسخ:

گزینه ۴ صحیح است. در یک مکان امن و محرمانه در محل کار (کلینیک) و بر اساس اصول رازداری. پرونده‌ها باید به گونه‌ای نگهداری شوند که دسترسی افراد غیرمجاز به آن‌ها ممکن نباشد. بردن پرونده‌ها به خانه یا نگهداری آن‌ها در مکانی ناامن، غیراصولی است. همچنین، پرونده‌ها پس از اتمام درمان حذف نمی‌شوند، بلکه برای یک دوره زمانی مشخص (معمولاً حداقل پنج سال) بایگانی می‌گردند.

۳۳. رفتار اخلاقی در مشاوره مستلزم چیست؟

- (۱) وفاداری کامل به مراجع در همه شرایط
- (۲) رعایت اصول راهنما و استانداردهای حرفه‌ای
- (۳) انعطاف در قوانین بر اساس علاقه شخصی
- (۴) تطبیق مداوم با خواسته‌های مراجع

پاسخ:

گزینه ۲ صحیح است. رعایت دقیق اصول، چارچوب‌ها و استانداردهای اخلاق حرفه‌ای. انعطاف‌پذیری در قوانین اخلاقی یا نادیده گرفتن آن‌ها تحت هیچ شرایطی پذیرفته نیست. این کدها برای حفاظت از مراجع و حفظ اعتبار حرفه تدوین شده‌اند و پایبندی به آن‌ها الزامی است.

۳۴. مهمترین نتیجه اخلاق حرفه‌ای در روان‌شناسی و مشاوره چیست؟

• (۱) پیشگیری از بروز بحران‌های اخلاقی و شکست درمانگر در درمان تخصصی

• (۲) پای‌بندی روان‌شناسان و مشاوران به اصول اخلاقی

• (۳) حمایت از حقوق مراجعان

• (۴) حل تعارض

پاسخ:

گزینه ۳ صحیح است. حمایت از حقوق مراجع. اگرچه پای‌بندی به اصول خود یک ارزش است، اما هدف غایی از تدوین و اجرای کدهای اخلاقی، محافظت از حقوق، کرامت و بهزیستی مراجعان، و همچنین مشاوران و خود حرفه است. این امر از طریق پای‌بندی عملی روان‌شناسان به این اصول محقق می‌شود.

۳۵. جمله زیر بیانگر کدام اصل اخلاق حرفه‌ای در روان‌شناسی و مشاوره است؟ «مراجع در انتخاب ادامه و اختتام جریان درمان کاملاً آزاد است و نباید او را برای دریافت خدمات روان‌شناختی و مشاوره مجبور کرد.»

• (۱) امساک

• (۲) آزادی انتخاب

• (۳) خود مختاری مراجع

• (۴) رشد شخصی

پاسخ:

گزینه ۳ صحیح است. اصل خودمختاری (Autonomy).

این اصل بر حق بنیادین مراجع برای گرفتن تصمیمات آگاهانه و آزادانه در مورد درمان خود، بدون اجبار یا فشار از سوی درمانگر، تأکید دارد. در واقع اصل خودمختاری در روان‌درمانی به این معناست که مراجع باید در فرآیند درمان، حق انتخاب و تصمیم‌گیری آزادانه داشته باشد و مشاور یا درمانگر نباید او را تحت فشار قرار دهد یا او را وادار به انجام کاری کند که با میل و اراده‌اش سازگار نیست. این اصل یکی از اصول اخلاق حرفه‌ای در روان‌درمانی است و بر اساس آن، احترام به استقلال و خودگردانی مراجع در اولویت قرار دارد

۳۶. بر اساس کدام اصل اخلاق حرفه‌ای تمام فعالیت‌ها و خدمات روان‌شناختی و مشاوره باید در جهت اصلاح، رشد و شکوفایی مراجع باشد؟

• (۱) رفاه مراجع

• (۲) صلاحیت حرفه‌ای

• (۳) خودارتقای

• (۴) سودمندی

پاسخ:

گزینه ۴ صحیح است. اصل سودمندی (Beneficence).

این اصل به معنای تعهد فعالانه درمانگر برای انجام کارهایی است که به نفع مراجع و بهزیستی او باشد و از وارد کردن هرگونه آسیب به او (اصل عدم ضرررسانی یا Non-maleficence) پرهیز کند.

۳۷. به لحاظ اخلاقی، مسئولیت جریان درمانی و مشاوره با چه کسی است؟

• (۱) مراجع

• (۲) روان شناس

• (۳) روان شناس و مراجع

• (۴) بر اساس رویکردهای مختلف روان درمانی و مشاوره متفاوت است.

پاسخ:

گزینه ۲ صحیح است. بر عهده روان شناس. درمانگر مسئولیت کامل فرآیند درمان، مدیریت زمان، حفظ چارچوب، تکنیک‌های به کار رفته و هدایت جلسات را بر عهده دارد و در قبال آن پاسخگو است.

۳۸. بهترین راه تنظیم مرز درمان کدام است؟

- (۱) سکوت در برابر ورود به مرزها
- (۲) خودافشایی زیاد درمانگر
- (۳) بیان صریح و محترمانه قوانین و نقش‌ها
- (۴) رفتار مبهم و دوگانه

پاسخ:

گزینه ۳ صحیح است. بیان صریح، شفاف و محترمانه قوانین و چارچوب‌ها در ابتدای درمان. رابطه مشاور و مراجع باید یک رابطه شفاف و مشخص باشد که در آن، نقش‌ها، مسئولیت‌ها و مرزها به وضوح تعریف شده‌اند.

۳۹. بر اساس آموزه‌های اخلاق حرفه‌ای «شراکت مالی»، «ارتباط دوستی» و «ارتباط آموزشی» با مراجع چگونه است؟

- (۱) در هر سه مورد ممنوع است.
- (۲) ارتباط آموزشی ایرادی ندارد.
- (۳) به توانمندی ایگوی مراجع بستگی دارد.
- (۴) بعد از اختتام روان‌درمانی و مشاوره ایراد ندارد.

پاسخ:

گزینه ۱ صحیح است. هر سه مورد ممنوع است. روان‌شناس نباید وارد هیچ‌گونه رابطه دوگانه‌ای (Dual Relationship) با مراجع خود شود. این ممنوعیت شامل روابط مالی، اجتماعی، آموزشی و شخصی می‌شود و حتی تا مدت زمان قابل توجهی (مثلاً دو سال) پس از خاتمه درمان نیز ادامه دارد، زیرا این روابط پتانسیل بالایی برای استثمار، آسیب به بی‌طرفی و مخدوش کردن مرزهای حرفه‌ای دارند.

۴۰. بر اساس آموزه‌های اخلاق حرفه‌ای «ارجاع» از مصادیق افشاء...

• (۱) می‌تواند نباشد

• (۲) می‌تواند باشد

• (۳) است

• (۴) نیست

پاسخ:

گزینه ۴ صحیح است. نیست. ارجاع دادن به خودی خود نقض رازداری نیست، زیرا با رضایت آگاهانه مراجع و برای تأمین بهترین منافع او انجام می‌شود و تبادل اطلاعات صرفاً در محدوده لازم برای ادامه درمان و با اطلاع مراجع صورت می‌گیرد.

۴۱. اتاق درمان با کدام ویژگی خلاقیت را در مراجع تقویت می‌کند؟

- (۱) دیوارهای سفید و خالی
 - (۲) کتابخانه پر از کتب تخصصی
 - (۳) میزهای رسمی و تجهیزات مجلل
 - (۴) محیطی گرم، منعطف و دارای فضا برای نوشتن یا نقاشی
- پاسخ:

گزینه ۴ صحیح است. ایجاد یک فضای گرم، پذیرا، صمیمی و منعطف. چنین فضایی به مراجع احساس امنیت و پذیرش می‌دهد و او را برای کاوش و بیان آزادانه خود ترغیب می‌کند که این خود زمینه‌ساز خلاقیت است. محیط خشک و رسمی می‌تواند بازدارنده باشد.

۴۲. کدام مورد بیانگر مصادیق «افشاء» یا عدم رازداری است؟

- (۱) می‌توان به مراجعی که هنوز درباره خود صحبت نکرده است اطمینان داد که تمام مطالبش نزد ما باقی خواهد ماند.
- (۲) نمی‌توان به مراجعی که هنوز درباره خود صحبت نکرده است اطمینان داد که تمام مطالبش نزد ما باقی خواهد ماند.
- (۳) به مراجع می‌توان تضمین داد که تمام مطالبش نزد ما باقی خواهد ماند.

• (۴) می‌توان در زمینه افشای اطلاعات با مراجع به توافق رسید

پاسخ:

گزینه ۲ صحیح است. درمانگر نمی‌تواند و نباید به مراجع قول رازداری مطلق و صددرصدی بدهد. او موظف است در ابتدای درمان و در فرآیند رضایت آگاهانه، اصل رازداری و همچنین حدود و استثنائات قانونی آن (مانند خطر آسیب جدی به خود یا دیگران، کودک‌آزاری و حکم دادگاه) را به روشنی برای مراجع توضیح دهد. قول رازداری مطلق، خود یک خطای اخلاقی است.

۴۳. یکی از اصول کلیدی اخلاق حرفه‌ای در روان‌درمانی کدام است؟

• (۱) احترام به استقلال مراجع در تصمیم‌گیری

• (۲) هدایت مراجع به تصمیم دلخواه درمانگر

• (۳) کنترل زندگی مراجع

• (۴) داوری سریع درباره رفتار مراجع

پاسخ:

گزینه ۱ صحیح است. احترام به استقلال مراجع در تصمیم‌گیری. این اصل که در فرآیندهایی مانند رضایت آگاهانه و حق انتخاب مراجع برای تصمیم‌گیری در مورد درمانش تجلی می‌یابد، یکی از پایه‌های اخلاق حرفه‌ای است.

۴۴. جمله زیر نشانگر کدام استاندارد اخلاقی است؟
«روان‌شناسان و مشاوران در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور فعالیت می‌کنند. بر همین اساس، لازم است با قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود آشنایی کامل داشته باشند.»

• (۱) روابط حرفه‌ای

• (۲) مداخله‌های روان‌شناختی

• (۳) مسئولیت

• (۴) صلاحیت

پاسخ:

گزینه ۳ صحیح است. اصل مسئولیت‌پذیری

(Responsibility). این اصل ایجاب می‌کند که روان‌شناس نه تنها در قبال مراجع، بلکه در قبال جامعه و قوانین حاکم بر حرفه خود نیز پاسخگو باشد و آگاهی از این قوانین بخشی از مسئولیت حرفه‌ای اوست.

۴۵. وقتی روانشناس یا مشاوره که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دانشجوی دکتری است خود را به عنوان «دکتر» معرفی می کند کدام استاندارد اخلاقی نقض می شود؟

• (۱) رازداری

• (۲) مسئولیت

• (۳) روابط حرفه ای

• (۴) صلاحیت

پاسخ:

گزینه ۴ صحیح است. اصل صلاحیت (Competence).

این اصل بیان می کند که روان شناسان باید توانایی ها و مدارک خود را به درستی و بدون اغراق معرفی کنند و از عناوینی که هنوز به طور کامل و رسمی احراز نکرده اند (یعنی فارغ التحصیل نشده اند)، استفاده ننمایند.

۴۶. کدام مورد در خصوص دانشجویان کارشناسی ارشد روان‌شناسی یا مشاوره در حال کارورزی که برای خود کارت ویزیت چاپ می‌کنند و خدمات روان‌شناسی و مشاوره ارائه می‌دهند، صحیح است؟

- (۱) اگر تبلیغات تحت نظارت سوپروایزر باشند عمل آنها غیراخلاقی نیست.
- (۲) اگر با نظارت مدیر مرکز خدمات انجام شود تبلیغات غیراخلاقی نیست.
- (۳) اگر خدمات رایگان باشد، تبلیغات اخلاقی است.
- (۴) هر نوع تبلیغات مجاز نیست.

پاسخ:

گزینه ۴ صحیح است. هر نوع تبلیغات مجاز نیست. کارورز تحت نظارت یک سوپروایزر فعالیت می‌کند و نمی‌تواند به صورت مستقل دفتر تأسیس کرده، برای خود تبلیغ کند یا مراجع جذب نماید. هر نوع فعالیت تبلیغی مستقل برای کارورزان مجاز نیست.

۴۷. در کدام مورد می‌توان «رازداری» را نادیده گرفت؟

- (۱) هنگامی که مراجع بالغ است و والدین به قصد کمک کردن خواستار آگاهی از رازهای او هستند.
- (۲) هنگامی که مراجع بیماری مسری دارد یا خطر جدی برای خود یا دیگران داشته باشد.
- (۳) هنگامی که دوستان صمیمی مراجع نگران مسائل و مشکلات مراجع هستند.
- (۴) هنگامی که همسر مراجع خواستار دریافت اطلاعات درباره مراجع است.

پاسخ:

گزینه ۲ صحیح است. وجود یک بیماری مسری که خطر جدی برای دیگران دارد. این مورد نیز یکی از استثنائات اصل رازداری است که در آن، سلامت عمومی بر محرمانگی اطلاعات فردی اولویت پیدا می‌کند.

سوالات صفحات بعد چون به متن کامل سوال و پاسخ‌ها، دسترسی نداشتیم، فقط به متن سوال و پاسخ درست اشاره می‌کنیم

سؤال ۴۸

مصاحبه علامت‌گرا (Symptom-Oriented Interview) بر چه مؤلفه‌هایی استوار است؟

پاسخ:

توصیف دقیق نشانه‌ها، علائم و رفتارهای قابل مشاهده مراجع. این نوع مصاحبه که هدف اصلی آن رسیدن به یک تشخیص دقیق بر اساس راهنماهایی مانند DSM است، بر جمع‌آوری داده‌های عینی (نشانه‌ها) و ذهنی (علائم) متمرکز است و با مصاحبه بینش‌گرا که به دنبال فهم تعارض‌های زیربنایی است، تفاوت دارد.

سؤال ۴۹

کدام رویکرد درمانی، تمرکز اصلی خود را بر دوران کودکی قرار می‌دهد؟

پاسخ:

رویکردهای بینش‌گرا (Insight-Oriented). این دسته از رویکردها، که شامل درمان‌های روان‌پویشی و تحلیلی است، بر این فرض استوارند که تعارضات حل‌نشده و تجربیات دوران کودکی، الگوهای رفتاری و هیجانی فرد در بزرگسالی را شکل می‌دهند.

سؤال ۵۰

اگر مراجع در جلسه درمان سکوت کند یا کم حرف باشد، بهترین واکنش چیست؟

پاسخ:

استفاده از پرسش‌های بازپاسخ (Open-Ended Questions). این نوع پرسش‌ها (مانند "چه چیزی باعث شده امروز به اینجا بیایید؟") مراجع را تشویق می‌کند تا به جای پاسخ‌های کوتاه «بله/خیر»، به توصیف و تشریح تجربیات خود بپردازد و فضای امنی برای گشایش و کاوش بیشتر فراهم می‌کند.

سؤال ۵۱

حداقل مدرک تحصیلی برای دریافت پروانه فعالیت از سازمان نظام روان‌شناسی چیست؟

پاسخ:

مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های روان‌شناسی یا مشاوره.

سؤال ۵۲

برای فردی که صرفاً با مشکل استرس (و نه یک اختلال اضطرابی مشخص) مراجعه کرده، کدام مداخله در اولویت است؟

پاسخ:

آموزش مهارت‌های آرام‌سازی (Relaxation). برای مدیریت استرس عمومی و غیرپیچیده، آموزش تکنیک‌های آرام‌سازی مانند تنفس عمیق یا آرام‌سازی پیشرونده عضلانی، یک مداخله اولیه، مؤثر، متمرکز و مبتنی بر اصل صرفه‌جویی (parsimony) است.

سؤال ۵۳

در کدام رویکرد درمانی به باورهای ناسازگار توجه می‌شود؟

پاسخ:

طرح‌واره‌درمانی (Schema Therapy). اگرچه CBT به افکار و باورهای ناکارآمد می‌پردازد، اما طرح‌واره‌درمانی به طور خاص بر شناسایی و تغییر «طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه» که الگوهای عمیق و ریشه‌داری هستند که در کودکی شکل گرفته‌اند، متمرکز است. گرچه منظور دقیق طراح سوال مشخص نیست و احتمال گزینه شناختی رفتاری هم هست.

سؤال ۵۴

چه زمانی یک روان‌شناس می‌تواند اطلاعات مراجع را در اختیار مراجع قضایی قرار دهد؟

پاسخ:

تنها با دریافت نامه رسمی و حکم از دادگاه. روان‌شناس نباید تحت فشار یا به درخواست مراجع یا هر فرد دیگری اطلاعات را افشا کند. افشای اطلاعات تنها در صورتی مجاز است که یک مرجع قانونی صالح، حکم کتبی ارائه دهد.

سؤال ۵۵

برای ارزیابی ویژگی‌های شخصیتی در جمعیت عمومی، کدام آزمون مناسب‌تر است؟

پاسخ:

پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا (MMPI). این آزمون یک ابزار گسترده برای ارزیابی آسیب‌شناسی روانی عمومی و صفات شخصیتی در جمعیت عمومی و بالینی است.

سؤال ۵۶

در مشاوره زوجی برای ارزیابی مشکلات شخصیتی یا ظن به اختلال شخصیت، کدام آزمون ارجح است؟

پاسخ:

آزمون بالینی چندمحوری میلون (Millon Clinical Multi-axial Inventory - MCMI). این آزمون به طور خاص برای ارزیابی اختلالات شخصیت و نشانه‌های بالینی منطبق با محورهاى DSM طراحی شده و هنجاریابی آن بر روی جمعیت بالینی صورت گرفته است، که آن را به ابزار انتخابی برای این هدف تبدیل می‌کند.

سؤال ۵۷

ارزیابی وضعیت روانی مراجع (Mental Status Examination) در چه زمانی از فرآیند درمان باید انجام شود؟

پاسخ:

در تمام جلسات. ارزیابی وضعیت روانی یک رویداد یکباره نیست، بلکه فرآیندی مداوم برای رصد تغییرات در وضعیت هیجانی، شناختی و رفتاری مراجع، سنجش پیشرفت درمان و ارزیابی خطرات احتمالی در طول فرآیند درمان است.

سؤال ۵۸

ابزاری که با عنوان «سَد پرسنز» (SADPERSONS) شناخته می‌شود، برای سنجش چه چیزی به کار می‌رود؟

پاسخ:

مقیاس SADPERSONS یکی از ابزارهای غربالگری و سنجش شدت خطر خودکشی است. این مقیاس یک ابزار یادآور (Mnemonic) برای ارزیابی سریع عوامل خطر خودکشی است. لازم به ذکر است که مطالعات جدید حساسیت و ارزش پیش‌بینی‌کنندگی آن را پایین ارزیابی کرده و استفاده از آن به تنهایی برای ارزیابی جامع خطر خودکشی توصیه نمی‌شود.

سؤال ۵۹

مراجعی که می‌گوید فرصت‌های زیادی را در زندگی از دست داده است، بیشتر نشانه کدام اختلال است؟

پاسخ:

افسردگی. نشخوار فکری درباره گذشته، احساس گناه و پشیمانی از ویژگی‌های شناختی بارز اختلال افسردگی اساسی است، در حالی که نگرانی درباره آینده بیشتر مشخصه اختلالات اضطرابی است.

سؤال ۶۰

اگر در جلسه روان درمانی متوجه افکار خودکشی مراجع شوید، اولین و بهترین اقدام چیست؟

پاسخ:

ارزیابی دقیق خطر خودکشی. قبل از هر اقدامی مانند اطلاع به خانواده، ارجاع فوری یا بستری کردن، اولین وظیفه درمانگر انجام یک ارزیابی جامع و دقیق از شدت، برنامه، قصد و دسترسی به ابزار خودکشی است. اقدامات بعدی بر اساس نتایج این ارزیابی صورت می گیرد.

سؤال ۶۱

استادی که صرفاً به دلیل دریافت هزینه، به فردی گواهینامه آموزشی اعطا می کند، چه حکمی دارد؟

پاسخ:

این کار جایز نیست و مصداق بارز تقلب، بدآموزی و تخلف حرفه ای است. اعطای گواهینامه باید منوط به احراز صلاحیت و گذراندن کامل دوره آموزشی باشد، نه صرفاً پرداخت هزینه.

کودکی به نام علی در مدرسه به معلم گوش نمی‌دهد، با دیگران دعوا می‌کند و رفتارهای تکانشی دارد. تشخیص محتمل چیست؟

پاسخ:

نافرمانی مقابله‌ای (ODD). مشخصه اصلی اختلال سازگاری، واکنش نامتناسب و نامطلوب فرد به یک یا چند عامل استرس‌زای قابل شناسایی در زندگی اوست. این واکنش معمولاً در قالب احساسات منفی، افکار آشفته، و تغییرات رفتاری بروز می‌کند و باعث اختلال در عملکرد روزمره فرد می‌شود. به عبارت دیگر، اختلال سازگاری زمانی تشخیص داده می‌شود که فرد به یک رویداد استرس‌زا، مانند از دست دادن شغل، طلاق، یا بیماری، واکنش بیش از حد نشان دهد و این واکنش باعث شود که در عملکرد شغلی، تحصیلی، یا اجتماعی او اختلال ایجاد شود. این واکنش معمولاً در عرض ۳ ماه پس از شروع عامل استرس‌زا ظاهر می‌شود و بیش از ۶ ماه طول نمی‌کشد. به طور خلاصه، مشخصه اصلی اختلال سازگاری، واکنش نامتناسب به یک عامل استرس‌زا و اختلال در عملکرد فرد به دلیل این واکنش است. مشخصه اصلی اختلال نافرمانی مقابله‌ای (ODD) الگوی رفتاری مداوم و مکرر نافرمانی، مخالفت و دشمنی نسبت به اقتدار است. این رفتارها اغلب شامل بحث و جدل با بزرگسالان، به ویژه والدین و معلمان، نافرمانی از دستورات، تحریک دیگران و عصبانیت و تحریک‌پذیری است. همچنین طبق متن DSM درجات شدت: خفیف علائم فقط در یک محیط (مثلاً در خانه) رخ می‌دهند. متوسط علائم در حداقل دو محیط (مثلاً در خانه و مدرسه) رخ می‌دهند. شدید علائم در سه محیط یا بیشتر (مثلاً در خانه، مدرسه و با همسالان) رخ می‌دهند.

سؤال ۶۳

اگر مراجع فاش کند که با یک فرد متأهل در رابطه عاطفی است، واکنش مناسب درمانگر چیست؟

پاسخ:

بررسی و کاوش بی طرفانه دلایل مراجع برای ورود و ماندن در چنین رابطه‌ای. نقش درمانگر، قضاوت اخلاقی، گزارش دادن یا ترغیب مراجع به قطع رابطه نیست، بلکه کمک به او برای رسیدن به بینش در مورد نیازها، الگوها و پیامدهای این انتخاب در زندگی‌اش است.

سؤال ۶۴

اگر مراجع یک سؤال شخصی از درمانگر بپرسد (مانند «آیا شما مواد مخدر مصرف می‌کنید؟»)، پاسخ مناسب چیست؟

پاسخ:

کاوش در مورد انگیزه و معنای سؤال برای مراجع، از طریق پرسشی مانند: «چه چیزی باعث شد این سؤال را از من بپرسید؟». این پاسخ، کانون توجه را از زندگی شخصی درمانگر به دنیای درونی مراجع بازمی‌گرداند و فرصتی برای بررسی نگرانی‌ها، ترس‌ها یا فرافکنی‌های احتمالی مراجع فراهم می‌کند.

سؤال ۶۵

کدام گزینه در مورد شرایط عضویت در سازمان نظام روان‌شناسی صحیح است؟

پاسخ:

عضویت برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته‌های روان‌شناسی و مشاوره امکان‌پذیر است. فارغ‌التحصیلان رشته‌های دیگر مانند علوم تربیتی یا علوم اجتماعی واجد شرایط عضویت نیستند.

سؤال ۶۶

سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره ایران چه نوع سازمانی است؟

پاسخ:

یک سازمان غیردولتی و مستقل است که بر اساس قانون مصوب مجلس، وظیفه ساماندهی، نظارت و صدور مجوز برای فعالیت حرفه‌ای روان‌شناسان و مشاوران را بر عهده دارد.

سؤال ۶۷

اگر فردی که از قبل تعارضات بین فردی داشته، دچار یک اختلال روانی (مانند افسردگی) شود، چه اتفاقی برای تعارضات او می افتد؟

پاسخ:

تعارضات بین فردی او تشدید شده یا گسترده تر می شود. اختلال روانی می تواند توانایی فرد برای مدیریت هیجانات، درک دیدگاه دیگران و حل مؤثر مشکلات را کاهش دهد و در نتیجه، مشکلات رابطه ای موجود را تشدید کند یا تعارضات قدیمی و حل نشده را مجدداً فعال سازد.

سؤال ۶۸

اگر درمانگر در حین درمان متوجه اشتباه خود شود، چه باید بکند؟

پاسخ:

پذیرش صادقانه و شفاف اشتباه و عذرخواهی از مراجع و تلاش برای اصلاح آن. این عمل نشان دهنده شفافیت، فروتنی و مسئولیت پذیری حرفه ای است و نه تنها به رابطه درمانی آسیب نمی زند، بلکه می تواند با الگوسازی یک رفتار سالم، آن را تقویت کند.

سؤال ۶۹

اگر زبان یا لهجه مراجع برای درمانگر نامفهوم باشد و ارتباط مؤثر را مختل کند، بهترین اقدام چیست؟

پاسخ:

ارجاع دادن مراجع به همکاری که با آن زبان یا لهجه آشناست. ادامه درمان در شرایطی که ارتباط کلامی مؤثر برقرار نیست، غیراخلاقی و غیرمؤثر است و به منافع مراجع آسیب می‌زند. استفاده از مترجم نیز می‌تواند یک گزینه باشد، اما با ملاحظات مربوط به رازداری همراه است.

سؤال ۷۰

اگر مراجع سؤال شخصی از روان‌شناس بپرسد، پاسخ صحیح چیست؟

پاسخ:

با احترام توضیح داده شود که این سؤال به فرآیند مشاوره مربوط نیست. درمانگر نباید به سؤالات شخصی پاسخ دهد، بلکه می‌تواند انگیزه پشت سؤال را مورد کاوش قرار دهد تا به درک بهتری از دنیای درونی مراجع دست یابد.

سؤال ۷۱

اگر پسر و دختری در مشاوره پیش از ازدواج از مشاور اصرار کنند که والدینشان را برای ازدواج راضی کند، واکنش صحیح چیست؟

پاسخ:

عدم دخالت مستقیم و راهنمایی زوج برای اینکه خودشان این مسئله را مدیریت کنند. نقش مشاور، توانمندسازی زوجین برای حل مشکلاتشان است، نه حل کردن مشکلات به جای آنها یا وساطت کردن.

سؤال ۷۲

وظیفه پیشگیری از خطر خودکشی در جامعه بر عهده چه کسی است؟

پاسخ:

یک وظیفه همگانی است. این مسئولیت تنها بر عهده متخصصان سلامت روان نیست، بلکه شامل تمام اعضای جامعه، از جمله پزشکان، مددکاران، خانواده و دوستان می شود که باید در شناسایی افراد در معرض خطر و حمایت از آنها نقش ایفا کنند.

سؤال ۷۳

اگر یک کودک در اتاق درمان اطلاعات ندهد و همکاری نکند،
راهکار اولیه چیست؟

پاسخ:

گرفتن اطلاعات از والدین. اگرچه استفاده از ابزارهای غیرکلامی مانند بازی و نقاشی برای ایجاد ارتباط با کودک بسیار مهم است، اما والدین منبع اطلاعاتی کلیدی و ضروری برای درک مشکل کودک و زمینه آن هستند. بنابراین، مصاحبه با والدین یک گام بنیادی در ارزیابی کودک است. چالش در این سوال گرفتن اطلاعات از والدین یا استفاده از ابزارهای غیرکلامی مانند بازی و نقاشی بود. شاید طراح بر خلاقیت تاکید دارد!

سؤال ۷۴

مهم‌ترین مؤلفه در اخلاق حرفه‌ای چیست؟

پاسخ:

مسئولیت‌پذیری (Responsibility). در میان اصول اخلاقی، مسئولیت‌پذیری به عنوان یک تعهد بنیادین برای حفظ منافع مراجع، پاسخگویی در قبال اقدامات حرفه‌ای و رعایت قوانین، مؤلفه‌ای محوری و درونی در نظر گرفته می‌شود.

سؤال ۷۵

کامل‌ترین مدل برای تبیین علت اختلالات روان‌شناختی چیست؟

پاسخ:

مدل زیستی-روانی-اجتماعی-معنوی. این مدل بر تعامل پیچیده عوامل بیولوژیک، روانشناختی و اجتماعی-فرهنگی و مباحث معنوی تأکید دارد. گرچه سه رکن اصلی و استاندارد که در تمام محافل علمی پذیرفته شده است، برخی متخصصان بعد معنوی (Spiritual) را نیز به آن اضافه می‌کنند.

سؤال ۷۶

اگر درمانگر، مراجع خود را به صورت اتفاقی در یک مکان عمومی ببیند، بهترین واکنش چیست؟

پاسخ:

یک احوالپرسی کوتاه، محترمانه و خنثی. درمانگر باید از ورود به صحبت‌های طولانی یا درمانی اجتناب کند تا حریم خصوصی مراجع و مرزهای حرفه‌ای رابطه حفظ شود. حق تقدم در شروع ارتباط با مراجع است تا او در موقعیت ناخوشایند قرار نگیرد.

سؤال ۷۷

اگر مراجع نخواهد در مورد مسائل خانودگی‌اش صحبت شود، آیا درمانگر می‌تواند دخالت کند؟

پاسخ:

خیر. مرز درمان یا مرز حرفه‌ای باید رعایت شود. رضایت آگاهانه در درمان بسیار مهم است.

سؤال ۷۸

چه کسی می‌تواند پروانه اشتغال دریافت کند؟

پاسخ:

فردی که حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی یا مشاوره را داشته و عضو سازمان نظام روان‌شناسی باشد. دانشجوی بودن برای دریافت پروانه کافی نیست.

سؤال ۷۹

اگر مراجع انجام تکلیفی را مغایر با باورهای مذهبی خود بداند، واکنش درمانگر چه باید باشد؟

پاسخ:

تکالیف باید با عقاید مذهبی مراجع تطبیق داده شوند. درمانگر موظف است به باورها و ارزش‌های مراجع احترام بگذارد و مداخلات درمانی را به شیوه‌ای حساس از نظر فرهنگی و مذهبی (بومی‌سازی) طراحی و اجرا کند.

سؤال ۸۰

اگر مراجع از درمانگر بخواهد در دادگاه علیه همسرش شهادت دهد، که او را در اتاق کتک زده است واکنش صحیح چیست؟
پاسخ:

عدم پذیرش درخواست، مگر اینکه از سوی دادگاه به صورت رسمی و کتبی احضار شود. درمانگر نباید به عنوان شاهد در دعاوی شخصی مراجع خود شرکت کند، زیرا این کار مرزهای درمانی را مخدوش کرده و او را از نقش بی طرف خارج می کند. تنها استثنا، حکم قانون و احضاریه دادگاه است.

سؤال ۸۱

مرجع صدور پروانه های اشتغال در حوزه روان شناسی و مشاوره کجاست؟
پاسخ:

سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران. این سازمان طبق قانون مصوب مجلس، تنها مرجع قانونی برای این امر است.

شاخص‌های اصلی سلامت روان کدامند؟

پاسخ:

هیجان، رفتار و فکر. بر پایه‌ی الگوی شناختی-رفتاری (Cognitive-Behavioral Model) این است که سه مؤلفه‌ی هیجان (Emotion)، رفتار (Behavior) و تفکر (Cognition) ارکان اصلی تشکیل‌دهنده‌ی سلامت روان محسوب می‌شوند. این سه مؤلفه به‌صورت متقابل و پویا با یکدیگر تعامل دارند و سلامت روانی در گرو تعادل، هماهنگی و سازگاری میان آن‌هاست. در این چارچوب، مؤلفه‌هایی نظیر انگیزش (Motivation) یا کارآمدی (Efficacy) ممکن است به‌عنوان پیامدهای عملکرد مطلوب این سه رکن اساسی در نظر گرفته شوند، اما جزء شاخص‌های بنیادین و ساختاری سلامت روان به‌شمار نمی‌آیند. بنابراین، گزینه‌ی «هیجان، رفتار و فکر» صحیح است، چرا که بیانگر اجزای اصلی و بنیادین مدل نظری رایج در تبیین و مداخله در حوزه‌ی سلامت روان است.

سؤال ۸۳

اگر زوج در جلسه اول به دنبال راهکار فوری برای طلاق باشد، واکنش صحیح چیست؟

پاسخ:

گوش دادن فعال و عدم ارائه راهکار فوری. وظیفه درمانگر در ابتدا، ایجاد فضا برای شنیدن کامل داستان مراجع و درک عمیق مشکل است. ارائه راهکار، به ویژه در مورد تصمیمات مهمی مانند طلاق، در جلسه اول اقدامی شتابزده و غیراخلاقی است.

سؤال ۸۴

آیا دانشجوی دکتری روان‌شناسی که هنوز دفاع نکرده، مجاز به استفاده از عنوان «دکتر» است؟

پاسخ:

خیر، مجاز نیست. تا زمانی که فرد به طور رسمی فارغ‌التحصیل نشده و مدرک خود را دریافت نکرده باشد، استفاده از این عنوان نقض «اصل صلاحیت» (Principle of Competence) محسوب می‌شود.

سؤال ۸۵

اگر مشاور مجرد باشد و مراجع هم مجرد باشد آیا مجاز است درخواست ازدواج کند؟

پاسخ:

خیر، اکیداً مجاز نیست. این عمل مصداق بارز رابطه دوگانه و سوءاستفاده از قدرت است و در تمام نظام‌نامه‌های اخلاقی ممنوع می‌باشد. این ممنوعیت شامل مراجع فعلی و حتی تا مدت زمان قابل توجهی پس از خاتمه درمان نیز می‌شود.

سؤال ۸۶

برای فعالیت حرفه‌ای در حوزه خدمات مشاوره چه چیزی لازم است؟

پاسخ:

هم عضویت در سازمان نظام روان‌شناسی و هم داشتن پروانه اشتغال. عضویت به تنهایی برای ارائه خدمات درمانی مستقل کافی و قانونی نیست.

سؤال ۸۷

برای تبدیل شدن به یک درمانگر حرفه‌ای، کدام مورد بیشترین کمک را می‌کند؟

پاسخ:

گذراندن دوره‌های آموزشی و کارورزی تحت نظارت. دانش نظری به تنهایی کافی نیست و کسب مهارت عملی از طریق کارورزی و آموزش‌های تخصصی برای تبدیل شدن به یک درمانگر شایسته، ضروری است. این سوال به گونه دیگر هم مطرح شده است. جایگاه کارورزی در گرفتن پروانه اشتغال کجاست؟ پیش نیاز درمانگری پاسخ بستری برای انتقال دانش است.

سؤال ۸۸

برای افزایش خلاقیت در کودکان در اتاق درمان چه باید کرد؟

پاسخ:

اتاق فضای نقاشی و بازی داشته باشیم. تشویق آن‌ها به تولید ایده‌های جدید. ایجاد فضایی امن و پذیرا که در آن کودک برای ایده‌پردازی و آزمون و خطا تشویق شود، به رشد خلاقیت او کمک می‌کند.

سؤال ۸۹

اگر شرکتی برای استخدام از تست MMPI استفاده کند و سؤالات برای متقاضیان تکراری و آشنا باشد، نتایج چه وضعیتی خواهند داشت؟

پاسخ:

نتایج تضعیف شده و احتمالاً نامعتبر هستند. آشنایی قبلی با سؤالات یک آزمون روان‌شناختی، به ویژه در زمینه‌های استخدامی، می‌تواند منجر به مدیریت پاسخ‌ها و کاهش اعتبار نتایج شود.

سؤال ۹۰

اگر مراجع در مورد موضوعی که درمانگر مطرح کرده بگوید «این نگرانی اصلی من نیست»، واکنش مناسب چیست؟

پاسخ:

احترام به نظر مراجع و عدم اصرار بر آن موضوع. درمان‌فرآیندی مشارکتی است و درمانگر باید به اولویت‌ها و دیدگاه مراجع احترام بگذارد. ضمن توضیح دلیل اهمیت موضوع از دیدگاه خود، در نهایت حق انتخاب با مراجع است.

سؤال ۹۱

کارکرد بررسی عاطفه (Affect) در ارزیابی وضعیت روانی چیست؟

پاسخ:

درک وضعیت هیجانی لحظه‌ای مراجع. عاطفه، تظاهر بیرونی و کوتاه‌مدت حالت هیجانی فرد است (مانند خوشحال، غمگین، بی تفاوت) و بررسی آن به درمانگر کمک می‌کند تا وضعیت هیجانی مراجع را در لحظه ارزیابی کند. این مفهوم با «خُلق» (Mood) که یک حالت هیجانی پایدارتر و طولانی‌مدت است، تفاوت دارد.

سؤال ۹۲

انتخاب رنگ روشن برای دیوار اتاق مشاوره چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟

پاسخ:

کمک به ارتباط بهتر و ایجاد حس گشودگی و آرامش در مراجع. محیط فیزیکی اتاق درمان می‌تواند بر فرآیند درمانی تأثیر بگذارد و رنگ‌های روشن و آرامش‌بخش می‌توانند به ایجاد فضایی امن و پذیرا کمک کنند.

سؤال ۹۳

اگر مراجع از موضوع اصلی بحث منحرف شود، چه باید کرد؟

پاسخ:

بازگرداندن محترمانه مراجع به موضوع اصلی با استفاده از سؤالات هدایتگرانه. یکی از وظایف درمانگر، نظم دادن به فرآیند جلسه و ذهن مراجع است. این کار باید با ظرافت و همدلی انجام شود تا مراجع احساس نکند که به حرف‌هایش بی‌توجهی شده است.

سؤال ۹۴

درمانگر و مراجع چه نوع رابطه‌ای می‌توانند با هم داشته باشند؟

پاسخ:

صرفاً رابطه حرفه‌ای مشاور و مراجع. هرگونه رابطه دیگری (دوستی، خانوادگی، کاری، مالی و غیره) به عنوان رابطه دوگانه تلقی شده و ممنوع است.

سؤال ۹۵

اگر مراجع زیر سن قانونی باشد، پیش‌نیاز شروع درمان چیست؟

پاسخ:

کسب رضایت آگاهانه از ولی یا قیم قانونی او. بر اساس قوانین و اصول اخلاقی، برای ارائه خدمات درمانی به افراد زیر سن قانونی، رضایت والدین یا سرپرست قانونی الزامی است.

سؤال ۹۶

وقتی متوجه می‌شوید که افرادی برای مشاوره ازدواج مراجعه کردند ولی مشکل دارند، چه اقدامی انجام می‌دهید؟

پاسخ:

به آنها کمک می‌کنیم و راهنمایی می‌دهیم تا خود تصمیم بگیرند. ما نباید به جای مراجع تصمیم بگیریم یا مستقیم اعلام کنیم که مناسب هم نیستند. تصمیم را باید به خود فرد واگذار کنیم.

سؤال ۹۷

برای اینکه سلامت روان جامعه را ارتقا بدهیم، سازمان نظام چه اقدامی باید انجام دهد؟

پاسخ:

در متن قانون سازمان آمده است هدف سازمان تلاش برای ارتقاء سطح دانش روانشناسی و مشاوره، حمایت از حقوق مراجعان به روانشناسان و مشاوران، حمایت از حقوق صنفی روانشناسان و مشاوران است و این موارد شامل اقدامات مختلف برای ارتقاء سلامت روان جامعه می‌شود.

سؤال ۹۸

اگر مراجعی در جلسه اول بگوید که با دوست خود دچار مشکل شده است، چه اقدامی انجام می‌دهید؟

پاسخ:

از مراجع می‌خواهیم تا در مورد مشکل بیشتر توضیح بدهد. دریافت شرح مشکل و تشویق مراجع به صحبت کردن اولین قدم است. سپس با توجه به فرآیند گفتگو به مراجع برای حل مشکل کمک می‌کنیم.

سؤال ۹۹

وقتی بین مراجع و درمانگر اختلافات قومیتی وجود داشته باشد...

پاسخ:

روی رابطه درمانگر و مراجع تأثیر دارد. بهترین حالت زمانی است که درمانگر برای مراجع خنثی باشد. هرگونه مسأله‌ای که روی رابطه درمانگر و مراجع تأثیر بگذارد، مانند رابطه دوستی یا سابقه همکاری یا اختلافات قومیتی، می‌تواند مسیر درمان را منحرف کند.

سؤال ۱۰۰

نشانه مؤثر بودن جلسات درمانی چیست؟

پاسخ:

مراجع احساس درک شدن می‌کند و به سمت تغییر حرکت می‌کند. در مورد این سوال، چون گزینه‌ها موجود نبوده، نمی‌توان با قطعیت بیشتر نظر داد.

سوال ۱۰۱

منظور از توافق درمانی بین مشاور و مراجعه چیست؟

پاسخ:

یعنی مشاوره و مراجع در مورد تعداد جلسات، هدف و روش های درمانی و حتی هزینه با هم به اشتراک نظر برسند. درمان فرایندی مشارکتی است و باید مراجع از هر آنچه قرار است رخ دهد اطلاع کسب کند و با رضایت و توافق مشخص و شفاف یا اصطلاحاً آگاهانه مسیر را پیش ببرد.

سوال ۱۰۲

در حال حاضر حل کردن کدام چالش کمک بیشتری به ارتقای سطح سلامت روان جامعه می کند؟

پاسخ:

نظارت بر دریافت مجوزها و ارتقا دانش و مهارت روانشناسان بر موضوعات دیگری مانند تحت پوشش قرار گرفتن خدمات روانشناختی و مقابله با روانشناسان زرد، اهمیت دارد زیرا کیفیت خدمات مهمتر است. البته این سوال نیز می تواند براساس نظر طراح فرق داشته باشد.

این فایل در نسخه های بعدی کامل تر و ویرایش خواهد شد.